

Répétitoire « Médecine générale »

*Prof Nicolas Senn
Institut universitaire de médecine de famille*



Tremor

Une patiente de 72 ans vous consulte parce qu'elle a des difficultés croissantes d'écrire à cause d'un tremblement. (plusieurs affirmations correctes possible)

A Dans l'anamnèse vous apprenez, que la mère a déjà souffert d'un tremor. Vous diagnostiquez alors une **maladie de Parkinson**.



B Le status neurologique est normal, en dehors d'un tremor fin à l'épreuve des mains tendus. Le diagnostic le plus probable est un **tremor essentiel**.



C La démarche diagnostic de tout tremor inclut ensuite un examen de sang et une imagerie cérébrale



D Comme traitement du tremor essentiel vous utilisez en premier lieu un bêta-bloquant (propanolol).



Tremor

Tremor au repos	M. Parkinson lent (3-8Hz), MS>MI, unilatéral, symptômes extrapyramidaux, neuroleptiques	Anticholinerg. (Biperiden = Akineton®) L- Dopa
Tremor postural - T. physiologique - T. essentiel (familial, sénile)	Emotions, café, β 2-stimulants, hyperthyroïdie (adrénerg.+) fin (8-12Hz), bilatéral Familial 50% (autosom.dominant), adolescent ou âgé, fin (8-12Hz), bilatéral	β -bloquants Primidone (Mysoline®) Benzodiazépines Topiramate OH (...)
Tremor intentionnel	Atteinte cérébelleuse (SEP, AVC), lent (<3Hz), mvt ↑	Ø
Mouvements anormaux, autres	Tics, asterixis, dyskinésies	

-> anamnèse ++, ex. clinique ++, labo (+), ENMG (+), IRM ((+))

Gastro-entérite

Un patient de 25 ans vous consulte pour des nausées, vomissements, diarrhées et température à 37,8° depuis 3 jours. Sa mère et 2 sœurs présentent la même chose.

Quelles affirmations sont pertinentes?

- A vous lui faites des examens de sang (leucos,CRP)
- B vous lui faites une culture des selles
- C vous le traitez de manière symptomatique
- D le virus le plus probable est le Norovirus
- E Test de PCR (panel virus-bactéries-parasites)



Gastro-entérite virale

- cause la plus fréquente de diarrhées et/ou vomissements.
- souvent accompagné de myalgies et céphalées
- pas d'examen complémentaire
- durée 7 à 10 jours
- traitement symptomatique (hydratation, loperamide)
- arrêt de travail impératif selon profession
- le virus le plus fréquent est le Norovirus
- si persistance, revoir le diagnostique
- **se méfier si retour de voyage**

Etiologie des diarrhées aiguës du voyageur

Etiologie		Prévalence
Bactéries	<i>Enterotoxigenic Escherichia coli</i> (ETEC)	12-34%
	<i>Enteraggregative E. coli</i> (EAEC)	1-24%
	<i>Campylobacter jejuni</i>	8-32%
	<i>Salmonella</i> spp.	4-9%
	<i>Shigella</i> spp.	2-14%
Virus	Norovirus	7-9%
	Rotavirus	13-17%
Parasites	<i>Giardia lamblia</i>	1-6%
	<i>Cryptosporidium</i> spp.	1-3%
	<i>Entamoeba histolytica</i>	1-4%

Etiologies des diarrhées persistantes du voyageur

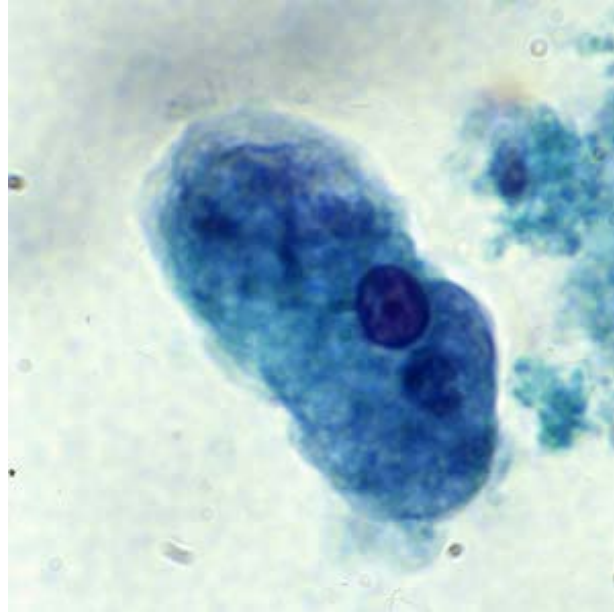
Etiologie		Prévalence
Parasites	<i>Giardia lamblia</i>	16%
	<i>Blastocystis hominis</i>	10%
	<i>Cyclospora cayetanensis</i>	3,5%
Bactéries	<i>Campylobacter jejuni</i>	6%
	<i>Shigella</i> spp.	3,5%

Quelles investigations
microbiologiques peut-on
proposer?

Investigations générales dans certains cas

- Vérification des signes vitaux
- Lors d'état fébrile ($T > 38^{\circ}\text{C}$)
 - Prise de sang: FSS, Na, K, créat
 - Hémocultures
 - Recherche de malaria si visite d'un pays endémique

Quizz: quels parasites?



Lequel est *entamoeba dispar* et *entamoeba histolytica* ?

Microscopie des selles

- Utilité
 - Permet l'identification de protozoaires et helminthes
- Problèmes
 - Sensibilité:
 - *Giardia*: 1 selle → 50%, 3 selles → 90%
 - *Entamoeba histolytica*: 90% avec 3 selles, mais pas possible de différencier les *E. histolytica* et *E. dispar*
 - Laborieux
 - Besoin de personnel qualifié et expérimenté
 - Coûts: env. CHF 90.- par selle

Culture de selles

- Avantages:
 - Permet de routine l'identification de Salmonelles, Shigelles et Campylobacter
 - Permet de faire un antibiogramme
- Problèmes:
 - Délai
 - Ne permet que de détecter un nombre très limité de pathogènes bactériens

PCR multiplex

- Principaux tests commercialisés en Suisse:
 - BioFire FilmArray (BioMérieux)
 - xTAG GI pathogen panel (Luminex)
 - BDmax (Beckton Dickenson)
- Détectent entre 3 et 22 pathogènes
- Prix: variation importante entre différents laboratoires.



Bactéries détectées par PCR multiplex

	BDmax	FilmArray GI	xTAG GPP
Bactéries			
<i>Campylobacter</i> spp. 1	x	x	x
<i>Salmonella</i> spp.	x	x	x
EIEC/ <i>Shigella</i> spp.	x	x	x
STEC/EHEC (stx1/stx2)	x	x	x
<i>E. coli</i> 0157		x	x
ETEC	x	x	x
EAEC		x	
EPEC		x	
<i>Aeromonas</i> spp.		x	
<i>Plesiomonas shigelloides</i>	x	x	
<i>Yersinia enterocolitica</i>	x	x	x
<i>Vibrio</i> spp. 2	x	x	x
<i>Clostridium difficile</i> (toxin A/B)	x (toxine B)	x	x

Protozoaires et virus détectés par PCR multiplex

Protozoaires:

	BDmax	FilmArray GI	xTAG GPP
<i>Cryptosporidium</i> spp. 3	x	x	x
<i>Entamoeba histolytica</i>	x	x	x
<i>Giardia lamblia</i>	x	x	x
<i>Cyclospora cayetanensis</i>		x	

Virus:

	BDmax	FilmArray GI	xTAG GPP
Adenovirus 40/41	x	x	x
Norovirus GI/GII	x	x	x
Rotavirus A	x	x	x
Sapovirus	x	x	
Astrovirus	x	x	

Avantages et inconvénients de la PCR multiplex

	TABLEAU 5	Avantages et inconvénients possibles des tests moléculaires rapides	
PROS		CONS	
Meilleure sensibilité		Détection de germes spécifiques (cibles prédéfinies → on ne trouve que ce que l'on cherche)	
Meilleure spécificité microbiologique (p. ex: <i>E. histolytica</i> versus <i>dispar</i>)		Pas d'information sur la viabilité (détection d'ADN/ARN)	
1 seul échantillon nécessaire (bactéries et protozoaires entériques)		Pas d'antibiogramme (culture bactérienne requise sur un échantillon positif par PCR)	
Rapide (1-3 heures)		Bénéfice clinique restant à démontrer	
Manipulations au laboratoire simplifiées		Risque de contamination si les précautions analytiques liées aux méthodes moléculaires ne sont pas respectées → Faux positifs	
Détection simultanée d'un grand nombre de germes (panel élargi permettant de mettre en évidence des germes inattendus)		Détection simultanée d'un grand nombre de germes (impossibilité de sélectionner les germes ayant une probabilité pré-test suffisante, résultat qualitatif empêchant de potentiellement distinguer un portage d'une vraie infection → lien de causalité pas clair)	

Une patiente se présente à votre consultation avec des nodules sous-cutanés douloureux de la région pré-tibiale ddc., d'apparition spontanée, récente., avec un état subfébrile et des arthralgies diffuses.





L'érythème noueux

Une patiente se présente à votre consultation avec des nodules sous-cutanés douloureux de la région pré-tibiale ddc., d'apparition spontanée, récente., avec un état subfébril et des arthralgies diffuses. Vous diagnostiquez un **erythème noueux**. Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes sont correctes :

- A. Il s'agit d'une pathologie fréquente en médecine de premier recours.
- B. Il faut toujours chercher une pharyngite streptococcique (clinique ou anamnestique)
- C. Les cas idiopathiques sont fréquents
- D. La guérison est habituellement spontanée.
- E. Une antibiothérapie est souvent nécessaire.



L'érythème noueux

Clinique : nodules sous-cutanées douloureux, rouges ou violacés, habituellement localisé sur la face tibiale antérieure, mais d'autres localisations sont possibles

Epidémiologie: incidence annuelle 1-5 / 100'000; ♀ 15 – 40 ans

DD: infections bactériennes sous-cutanées, phlébites, vasculites, (dont vasculite nodulaire)

Etiologie: infection streptococcique récente (pharyngite)
> idiopathiques (17-72%) >> autres infections, sarcoïdose, Tbc, maladies systémiques, médicaments

Evolution: guérison soit spontanée ou avec la guérison d'une éventuelle cause sous-jacente.

Une antibiothérapie n'est en générale pas nécessaire

Borrélioses

Lesquelles des propositions suivantes sont correctes

- A. Une notion anamnétique de morsure par une tique est indispensable au diagnostic de maladie de Lyme 
- B. La transmission des spirochètes se fait essentiellement dans les 24 premières heures de fixation de la tique 
- C. L'érythème migrant (EM) typique mesure au moins 5 cm de diamètre; il est annulaire. 
- D. Afin d'éviter tout traitement inutile, une sérologie est nécessaire avant traitement de tout érythème migrant 

Borrélioses

Non. Dans **50% des EM typiques**, même documentés par la sérologie, **aucune notion anamnestique de morsure** par une tique ne peut être obtenue du patient.

Non. Le nourrissage par la tique (et la régurgitation secondaire des spirochètes par le rostre) ne commence habituellement **qu'après 36 heures de fixation**. Et le risque d'une maladie de Lyme de ce fait n'apparaît le plus souvent qu'après ce délai, surtout si la tique n'est pas gorgée de sang (tique restée petite). Pas de traitement de première intention dans ce cas.

Correct. La progression est lente (sur plusieurs jours), centrifuge (centre secondairement plus pâle). La rougeur initiale du site de morsure, punctiforme, ne traduit qu'une inflammation non-spécifique type « piqûre d'insecte » (Ixodes est un acarien, pas un insecte!). Ce n'est pas un EM!

Non. La décision de traiter se base sur la clinique. En effet **50% des vrais EM ont une sérologie encore négative deux semaines après** l'apparition des symptômes. D'où risque de sous-traiter. Inversement: risque des faux positifs (« cicatrice » sérologique d'anciennes infections guéries) et donc de surtraiter.

Borrélioses

- A. La borréliose de Lyme aiguë se présente fréquemment sous la forme d'une polyarthrite (diagnostic différentiel: polyarthrite rhumatismale) 
- B. La borréliose de Lyme est une des causes tant de la fibromyalgie que du syndrome de fatigue chronique 
- C. D'autres affections peuvent être transmises simultanément par les tiques porteuses de *Borrelia burgdorferi* 
- D. La maladie de Lyme est une des causes de la paralysie faciale (*α frigore*) 
- E. La vaccination contre la maladie de Lyme est efficace et doit être recommandée chez les professionnels de la forêt (bûcherons,...) en zone d'endémie 

Borrélioses

- A. **Non.** Il s'agit le plus souvent d'une mono ou oligoarthritis (alors asymétrique), touchant souvent le genou; il n'y a jamais plus de trois articulations atteintes. Là où le diagnostic de PR nécessite au moins trois séries d'articulations, symétriques.
- B. **Non.** Aucune évidence étiologique. Attention à ne pas évoquer ce lien (inexistant) auprès de patients qui deviendraient alors demandeurs de traitements antibiotiques inutiles
- C. **Oui**, parmi lesquelles: Encéphalite à tiques, Babésiose, Rickettsioses, anaplasmose, ...
- D. **Oui**, la paralysie faciale peut être en lien avec une maladie de Lyme, même si une notion de morsure par une tique n'est qu'épisodiquement retrouvée.
- E. **Non**, il n'y a pas de vaccin contre la maladie de Lyme (ancien vaccin peu efficace aux USA, depuis retiré). Par contre la vaccination est recommandée, aux groupes à risque, contre l'encéphalite à tique.

L'ulcère de décubitus

Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes sont correctes au sujet de l'ulcère de décubitus:

- A. La présentation clinique initiale est un érythème permanent. 
- B. L'âge, en soi, n'est pas un facteur qui contribue au développement des ulcères de décubitus. 
- C. Les facteurs qui contribuent au développement des ulcères de décubitus incluent une pression en regard d'une proéminence osseuse, une peau moite, une immobilisation en position assise ou allongée prolongée. 
- D. Un ulcère de décubitus peut conduire à une ostéomyélite, une bactériémie et même une méningite. 

L'ulcère de décubitus

- A. Un érythème « qui ne blanchit pas » constitue en effet le stade initial typique d'une souffrance de décubitus
- B. L'âge, en soi, ne constitue en effet en aucune manière un facteur causal direct pour le développement d'une lésion de décubitus
- C. Une pression, une peau moite (souillure par les urines), une immobilisation prolongée constituent effectivement des facteurs qui contribuent au développement des ulcères de décubitus
- D. Une ostéomyélite, une bactériémie ou une méningite sont des complications possibles d'un ulcère de décubitus

Arthrose

Un homme de 55 ans vient à la consultation se plaignant de douleurs du genou gauche, avec une tuméfaction occasionnelle intermittente. Il mentionne aussi une douleur inguinale D à la marche, particulièrement le matin en se levant ou en ressortant de sa voiture. Il a eu une fracture du plateau tibial à l'âge de 24 ans. Malgré ces douleurs il a continué à exercer son activité de menuisier.

- A. Le labo ne montre pas de syndrome inflammatoire ce qui permet d'exclure une arthrose à l'origine de ces douleurs 
- B. L'ancienne fracture tibiale augmente le risque de développer une arthrose 
- C. L'examen de la mobilité du genou met en évidence une limitation de la flexion. La Rx de face est décrite comme presque normale hormis une discrète diminution de l'interligne articulaire. Vous ne pouvez donc pas retenir un diagnostic d'arthrose 
- D. Dans cette situation le traitement de premier choix est un chondroprotecteur associé à une cure de cortisone, en infiltration 
- E. Vous devez présenter rapidement le patient à un chirurgien pour qu'il intervienne avant une aggravation 

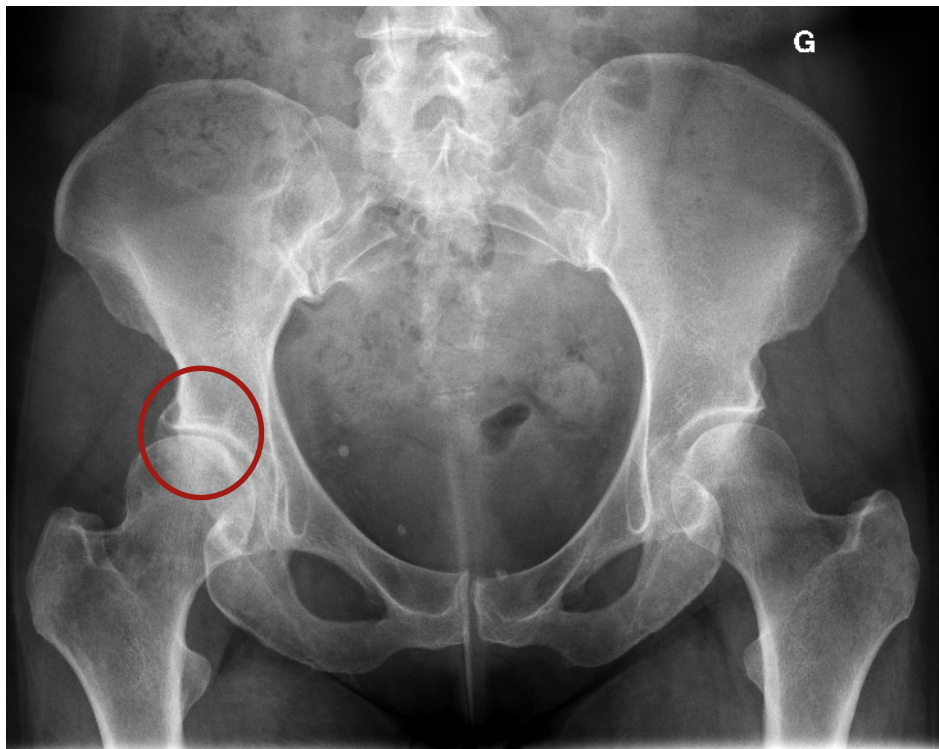
Arthrose

- A. **Faux**, L'arthrose n'est pas liée à un syndrome inflammatoire (VS, CRP). Sa présence devrait nous inciter à exclure une maladie rhumatismale.
- B. **Vrai**, toute anomalie intra-articulaire (YC ménisectomie, ancienne arthrite septique, malformation) de même que les défauts d'axe favorisent l'arthrose
- C. **Faux**, il y a une mauvaise corrélation entre la clinique et la radiologie lors des problèmes d'arthrose, particulièrement débutante. S'il n'y a qu'une atteinte cartilagineuse, la radiographie peut être normale avec une atteinte cartilagineuse sévère
- D. **Faux**, en première intention, il faut prescrire paracétamol / AINS et physiothérapie; les chondroprotecteurs n'ont jamais démontré d'efficacité
- E. **Faux**, le chirurgien ne pourra pas prévenir d'évolution défavorable, sauf en cas de défaut d'axe significatif (Discuter une ostéotomie chez un patient jeune)

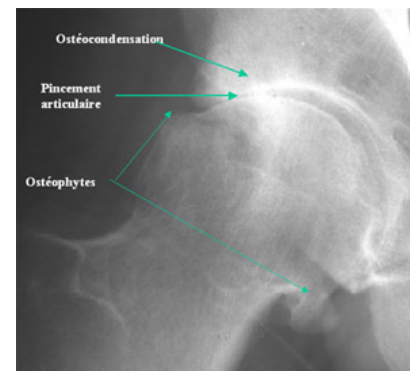
Quel diagnostic différentiel des douleurs de la hanche

Tableau 2. Diagnostic différentiel d'une douleur localisée dans la région de la périhanche

Douleurs postérieures (fesse)	Douleurs latérales	Douleurs antérieures
• Lombalgie basse (L4-S1) irradiant dans la fesse • Syndrome de Maigne (irradiation d'une douleur D12-L1) • Dysfonction sacro-iliaque • Sacro-iliite • Syndrome du pyramidal • Syndrome radiculaire L5 ou S1	• Syndrome de la bandelette iliotibiale • Méralgie paresthésique	• Coxarthrose • Ostéonécrose aseptique • Bursite de l'iliopsoas • Tendinopathie du muscle droit antérieur



Diagnostic possible:
Coxarthrose



**!! Mauvaise corrélation
entre image Rx et
douleurs!!**

Quel traitement de l'arthrose ?

Médicaments

AINS
(Paracétamol)

Soutien

Encourager la marche
Éventuellement
physiothérapie

Le diclofénac 150mg/j
semble être le plus efficace

L'etoricoxib 60mg/j arrive en
second

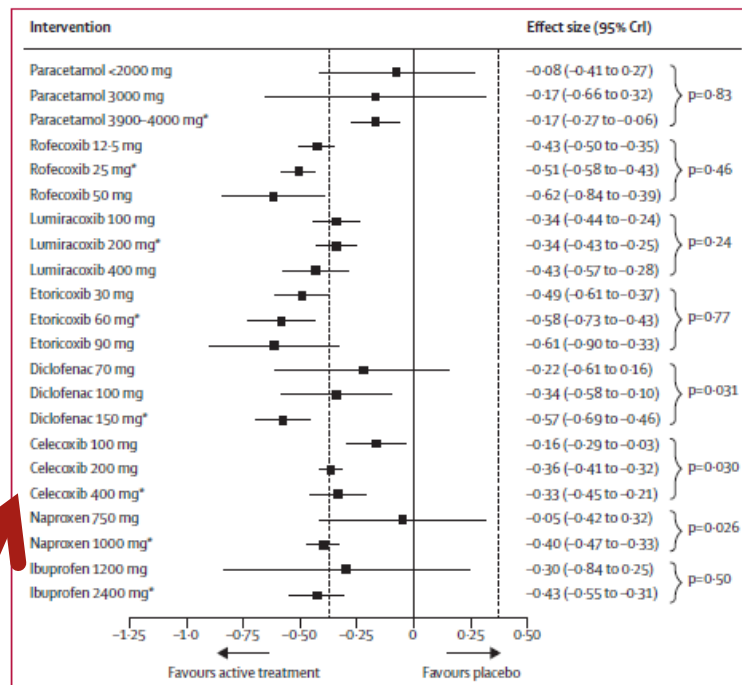


Figure 2: Estimates of the treatment effects on pain for different daily doses of NSAIDs and paracetamol compared with placebo. Analysis considers data from all timepoints as available. Area between dashed lines shows the treatment effect estimates below the minimum clinically important difference. Two-sided p values are derived from tests of linear dose-effect. NSAID=non-steroidal anti-inflammatory drug. CrI=credibility interval. *Maximum approved daily dose.

Stomatite aphteuse

Une femme de 32 ans, fumeuse, vous consulte pour des aphtes buccaux douloureux qui la gênent depuis 8 jours. A l'examen vous notez des aphtes ulcératifs couverts d'une membrane gris-jaunâtre avec un halo rouge, sur la muqueuse des joues et sur le palais dur. Il y en a 6 en tout. Lesquelles des affirmations suivantes sont correctes:

A. Il faut évoquer un herpès dans le diagnostic différentiel.



B. Si cette patiente se plaint de brûlures vaginales on peut évoquer un syndrome de Behçet.



C. On doit évoquer un carcinome vu le tabagisme.



D. Une stomatite aphteuse doit guérir en 24 heures.



Stomatite aphteuse

- 20% de la population en souffre au moins une fois dans sa vie
- la guérison peut durer jusqu'à 5 semaines (en moyenne 2)
- il faut évoquer un pemphigus s'il y a des lésions bulleuses ailleurs
- l'aphtose du syndrome de Behçet est identique à la stomatite aphteuse mais il faut aussi une atteinte oculaire et génitale
- le carcinome de la cavité buccale est une lésion unique ulcéralive
- on peut évoquer le syndrome mains-pieds-bouche si des lésions érythémateuses apparaissent aussi sur les mains, les pieds et les lèvres (entérovirus : souvent associé à gastroentérite)
- le traitement de la stomatite aphteuse est symptomatique



Diag: Angine herpétique



Diag:
Gingivostomatite
herpétique



Diag: aphte idiopathique



Diag: Pamphigus vulgaire



Diag: Langue géographique



Leucoplasie

Paralysie faciale

Un homme de 50 ans vous consulte le matin à cause d'une paralysie de l'hémiface droite, apparue durant la nuit; il ne présente pas de céphalées ni de fièvre.

- A L'examen neurologique révèle une paralysie de toute la musculature de l'hémiface, avec effacement des rides, ouverture de l'œil, sillon nasogénien aboli et déviation de la bouche à gauche. Vous posez le diagnostic d'une **paralysie de Bell** et pouvez renoncer à tout complément d'examen clinique. 
- B Vous devez effectuer d'urgence un IRM cérébral 
- C La plupart des cas de paralysie de Bell sont dus à une infection à B. burgdorferi 
- D Vous laissez le patient rentrer avec son diagnostic, sans traitement, comme l'évolution spontanée est favorable dans la majorité des cas. 

Paralysie faciale

Paralysie de Bell: > 70% des paralysies faciales périphériques

- Clinique: apparition brusque, unilatérale, hémiface entière, Bell +, st. neurol. & ORL autrement sp, Ø T°
- Etiologie: **HSV1**, Borrelia, HIV, diabète, syphilis, diabète
- DD: - atteinte centrale (vasc., inflamm.): Ø front !!
- inf. SNC, otite, zona, tu parotide, traumatisme,
- Examen clinique: st. neurol (complet!) & ORL (tympan!)
Laboratoire: selon situation (HbA1c, sérol. Borrelia, HIV, etc.)
ENMG, IRM ((+)), PL ((+))
- Traitement: Prednisone (60 mg/j) + valacyclovir (3x1 g/j)
Protection de l'œil
Physiothérapie
- Pronostic: Récupération spontanée complète: 63% (3m)/80% (9m)
Récupération avec TTT: 83% (3m), 95% (9m)



Syndrome des jambes sans repos (SJSR)

Une patiente de 60 ans vous consulte à cause de troubles du sommeil. Elle n'arrive plus à s'endormir à cause de tiraillements dans les jambes qui l'obligent à se lever.

Vous diagnostiquez un **syndrome des jambes sans repos** (« restless legs syndrome »). Quelles sont les affirmations correctes à ce sujet ?

- A. Le syndrome est fréquent, surtout chez la femme
- B. Le diagnostic d'un SJSR se fait par un examen ENMG
- C. Les symptômes s'améliorent avec le repos
- D. Lors d'un diagnostic de SJSR, on doit rechercher les signes cliniques d'une maladie de Parkinson



Syndrome des jambes sans repos

- Critères :**
- besoin urgent et irrésistible de mobiliser les jambes
 - manifestation exclusivement au repos
 - amélioration ou disparition lors de mouvements des jambes
 - début ou aggravation le soir.

Etiologie: inconnue, il touche 2 à 15% de la population et prédomine chez la femme (2:1). Sa prévalence augmente avec l'âge jusqu'à 79 ans, puis diminue, sans explication connue.

Perturbation dopamine (Parkinson !). Si présence concomitante, la MP précède le syndrome des jambes sans repos dans 68%.

Facteurs aggravants: repos, carence en fer, médicaments (antihistaminiques, neuroleptiques, antidépresseurs), caféine, nicotine et alcool

- Traitements:**
- non-pharmacologique: cf supra
 - L-dopa et agonistes dopaminergiques
 - Antiépileptiques (gabapentine), benzodiazépines



Troubles mnésiques

Un homme de 68 ans consulte car il est inquiet de voir sa mémoire baisser. Il a de la peine à se souvenir où il met ses affaires. Autrement il est totalement indépendant pour ses activités quotidiennes. Ses antécédents incluent une HTA et une hypothyroïdie bien contrôlées par hydrochlorothiazide, lisinopril, et levothyroxine.

Son score de Mini-Mental State est de 25/30. Le reste de l'examen est normal. Ses tests de laboratoire incluant une formule sanguine complète, tests hépatiques, urée, créatinine, électrolytes, calcium et TSH, étaient tous normaux il y a 3 mois. Parmi ces attitudes, lesquelles sont correctes:

- A. Prescription de donepezil (Aricept®)
- B. Dépistage de la dépression
- C. IRM cérébrale
- D. Dosages de VDRL, acide folique, vitamine B12



Troubles mnésiques

- **Causes:**
 - Maladie Alzheimer
 - Lésions vasculaires multiples
 - Maladie de Parkinson
 - Chorée de Huntington
 - « Mild cognitive impairment » (MCI): troubles mnésiques physiologiques liés au vieillissement; bonne performance activités quotidiennes; résolution=40%, évolution vers démence=12%, réhabilitation cognitive +/- efficace
- **Diagnostic: distinguer formes bénignes & sérieuses**
 - Anamnèse de l'entourage, suivi clinique
 - MMS: 24-25=MCI, 19-24=démence légère, 10-19=démence modérée
 - Labo: FSC, électrolytes, TSH, folates, vitB12, VDRL, sérologie VIH
 - Imagerie cérébrale éventuelle

Bonne chance..